

Oreille

ECOS

Anamnèse ciblée

- Acouphène (sifflement, bourdonnement)
- Otalgie
- Sécrétion – écoulement – otorrhée
- Vertiges
- Hypoacousie (!!! AVC)
 - Trauma
 - Exposition à bruit +++

Anamnèse générale

- Fièvre
- Oodynodysphagie
- IVRS récente?
- Contexte

Anamnèse neuro

- **Céphalées**
- Perte de force
- Perte de sensibilité
- Trouble visuel
- Trouble phasique

A close-up photograph of a human ear, showing the external structures including the helix, anthelix, concha, tragus, and anti-tragus. The ear is set against a background of dark hair and skin. A black text box is overlaid at the bottom of the image.

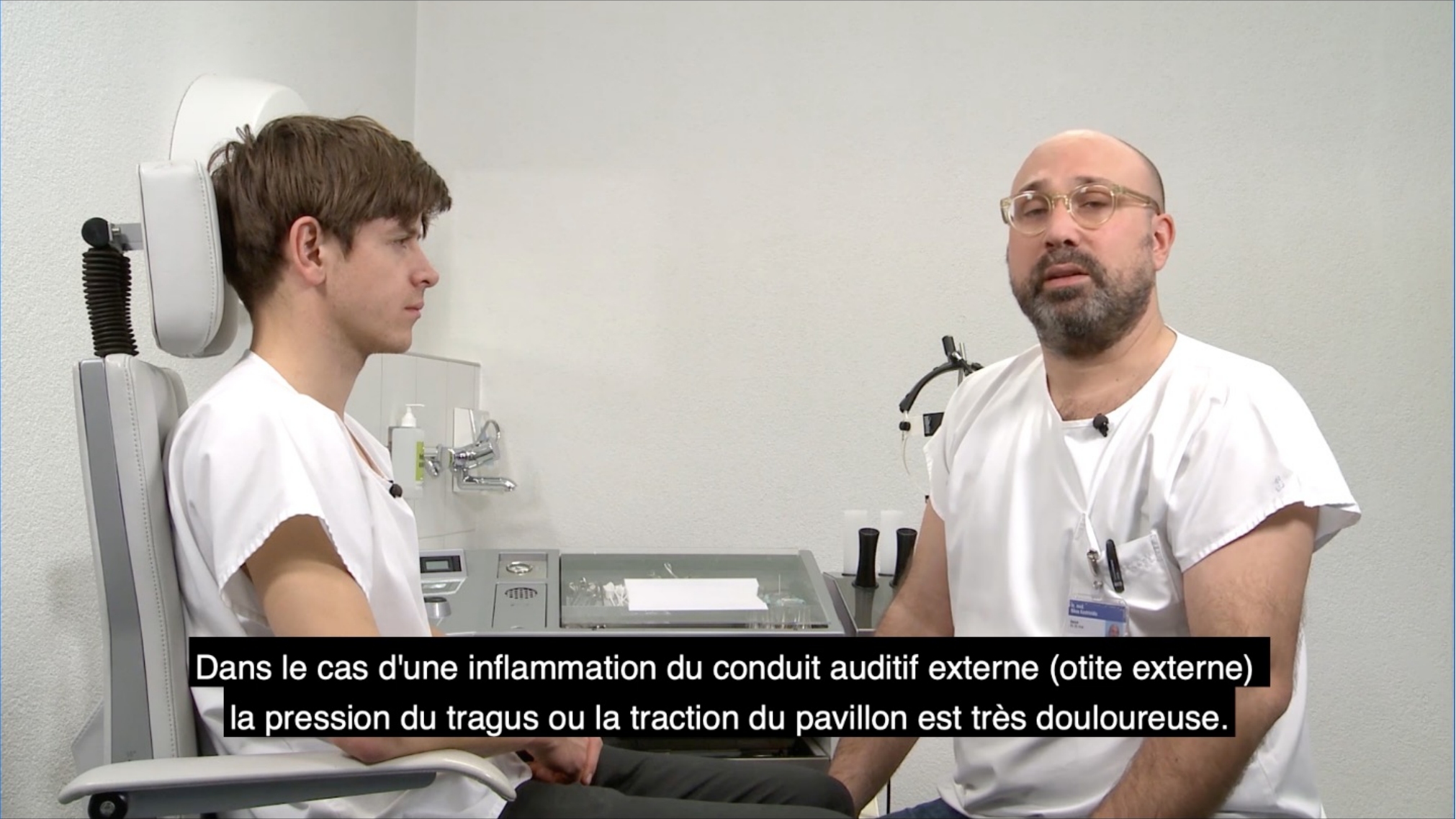
L'examen de l'oreille commence par l'inspection du pavillon avec l'hélix, l'anthélix, la conque du pavillon, tragus, l'anti-tragus et finalement le lobe.

A medical professional, a man with glasses and a beard wearing a white short-sleeved shirt, is examining a patient's head. The patient is seated in a white medical chair, facing away from the camera. The professional is using both hands to palpate the retroauricular region (behind the ear) of the patient. The setting appears to be a clinical examination room with a white wall, a sink, and a blue door in the background. A small anatomical chart is visible on the blue door.

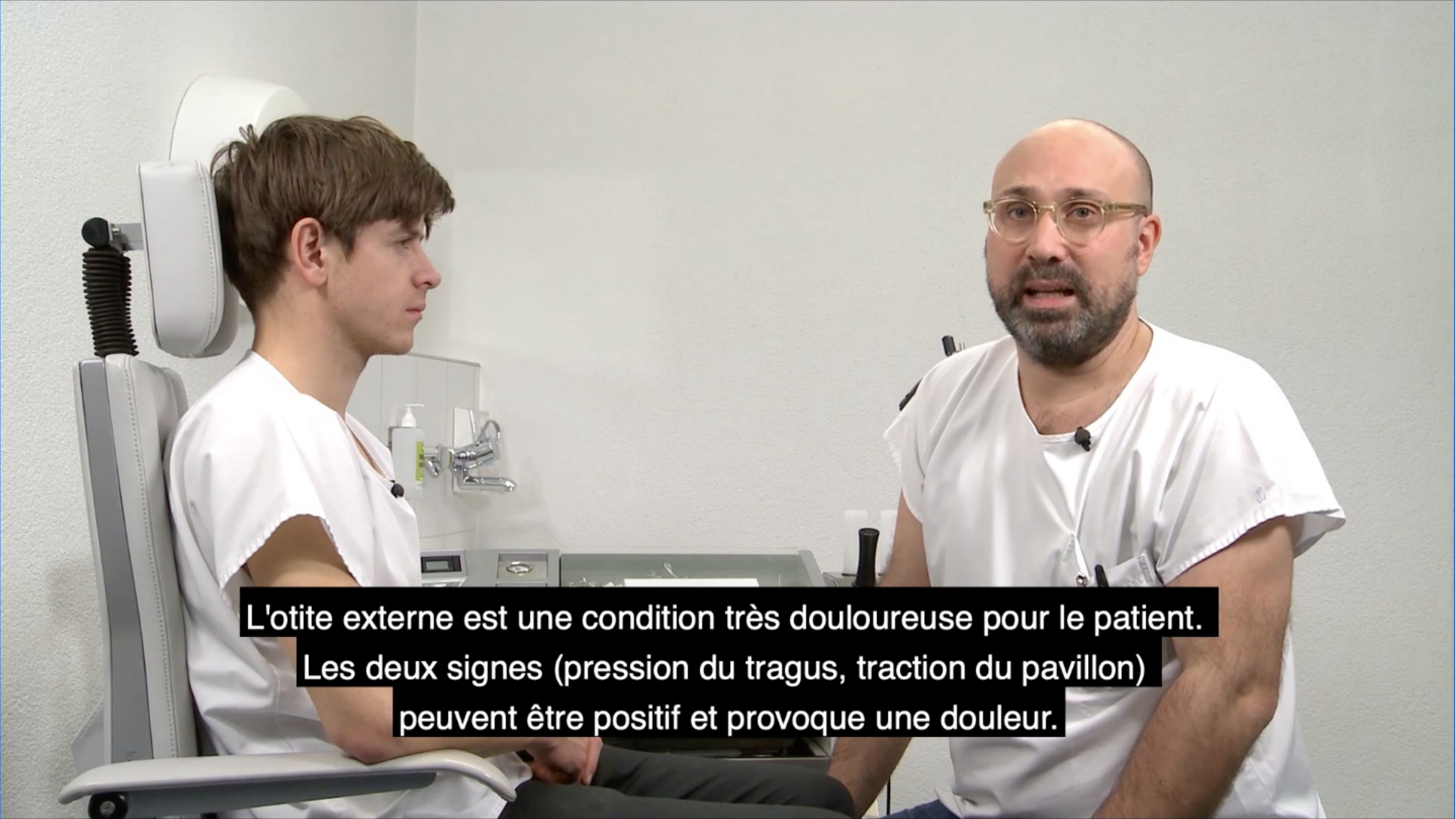
La mastoïde qui se trouve dans la région rétro-auriculaire doit être inspectée.
En cas de mastoïdite, la mastoïde peut être erythémateuse,
tuméfiée avec un décollement du pavillon.



Ensuite, il faut percuter la mastoïde à la recherche de douleur.



Dans le cas d'une inflammation du conduit auditif externe (otite externe) la pression du tragus ou la traction du pavillon est très douloureuse.



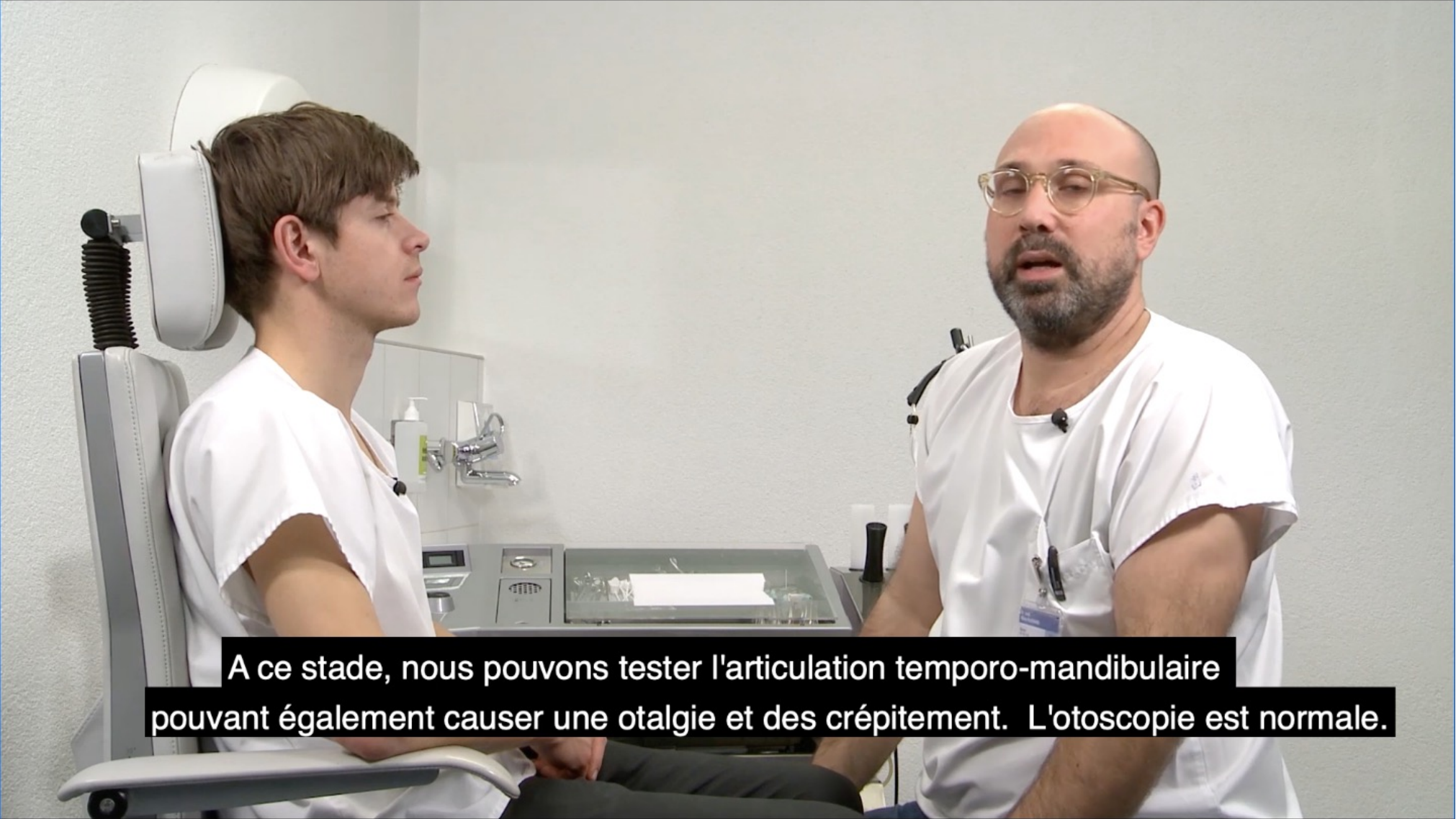
L'otite externe est une condition très douloureuse pour le patient.
Les deux signes (pression du tragus, traction du pavillon)
peuvent être positifs et provoquent une douleur.

A close-up photograph of a person's head, focusing on the ear. A finger is pulling the earlobe forward, demonstrating the traction of the pavilion. The skin on the face is fair with some freckles, and the hair is dark brown. The background is a plain, light-colored surface.

et voici la traction du pavillon.

A close-up photograph of a person's ear. A finger is pressing against the tragus, the small cartilaginous point in front of the ear canal. The ear is pink and appears healthy. The person has brown hair.

Nous réalisons une pression du tragus. Avez-vous mal? non

A medical professional, a man with a beard and glasses wearing a white short-sleeved shirt, is seated and talking to a young male patient. The patient is seated in a specialized dental or medical chair, also wearing a white short-sleeved shirt. They are in a clinical room with a sink and medical equipment visible in the background. A black text box with white text is overlaid at the bottom of the image.

A ce stade, nous pouvons tester l'articulation temporo-mandibulaire pouvant également causer une otalgie et des crépitements. L'otoscopie est normale.



Le patient ouvre la bouche avec une légère pression sur l'articulation.



Pouvez-vous ouvrir et fermer la bouche?

A medical examination scene. On the left, a young man with brown hair, wearing a white short-sleeved shirt, is seated in a white dental chair, facing right. On the right, a middle-aged man with a beard and glasses, also wearing a white short-sleeved shirt, is seated and facing the patient. The background is a clinical setting with a white wall, a sink, and a mirror. A black text box with white text is overlaid at the bottom of the image.

Une douleur élicitée lors de cet examen peuvent être un signe d'une dysfonction ou inflammation de l'articulation temporo-mandibulaire.

A medical professional, a man with a beard and glasses wearing white scrubs, is speaking to a young male patient. The patient is seated in a white medical chair, also wearing white scrubs. They are in a clinical setting with a sink and medical equipment visible in the background. A black text box with white text is overlaid at the bottom of the frame.

Ce diagnostic doit être suspecté lorsqu'un patient avec otalgie présente une otoscopie normale.

WEBER



Le test du diapason selon Weber est un test précieux, en particulier pour les troubles auditifs unilatéraux. Le son du diapason, qui est placé au milieu du crâne sur le vertex, est conduit aux deux oreilles internes par conduction osseuse avec la même intensité.

WEBER

Schwerhörigkeit:
Schallempfindung



Si le patient a une perte auditive unilatérale, il ressentira le son plus fort du côté sain.
Il se latéralise dans l'oreille saine.

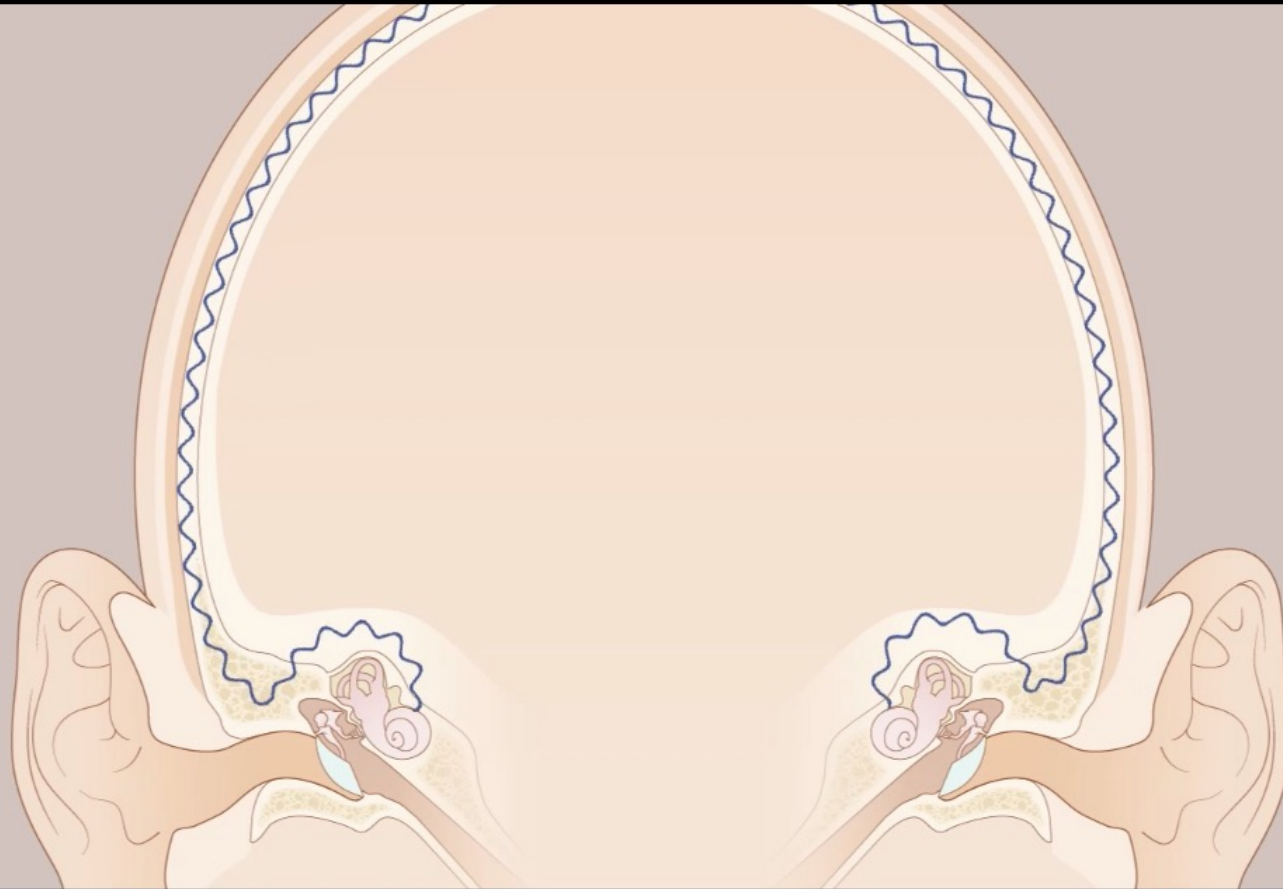
WEBER



Schwerhörigkeit:
Schallleitung

Cependant, si la perte auditive unilatérale est d'origine conductrice,
le son dans l'oreille malentendante est perçu plus fort.

WEBER



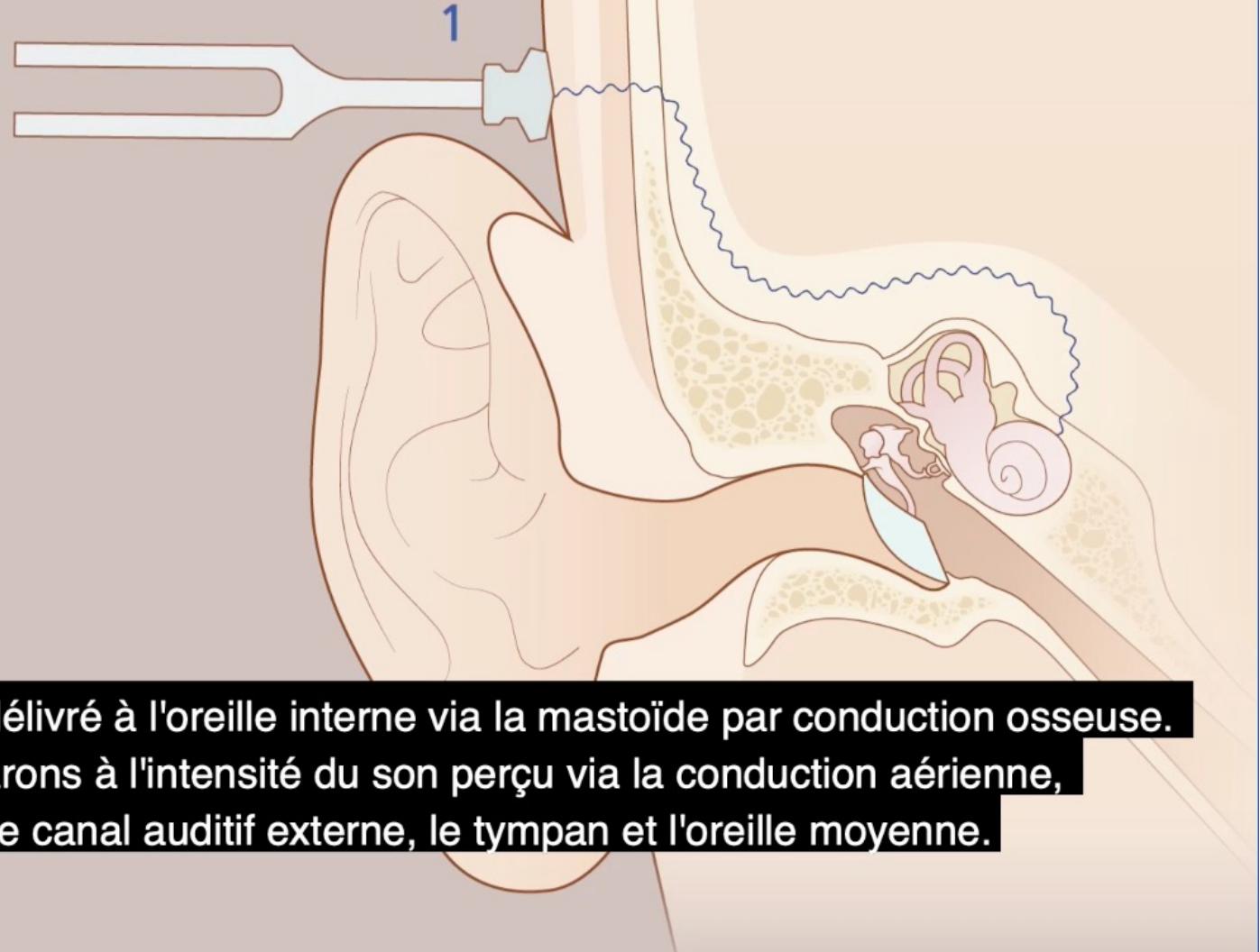
Un patient entendra le son au milieu s'il a une audition normale ou une perte auditive bilatérale symétrique. Le Weber est alors centré.

RINNE



Le test du diapason selon Rinné est basé sur la comparaison de la conduction aérienne et osseuse de la même oreille.

RINNE

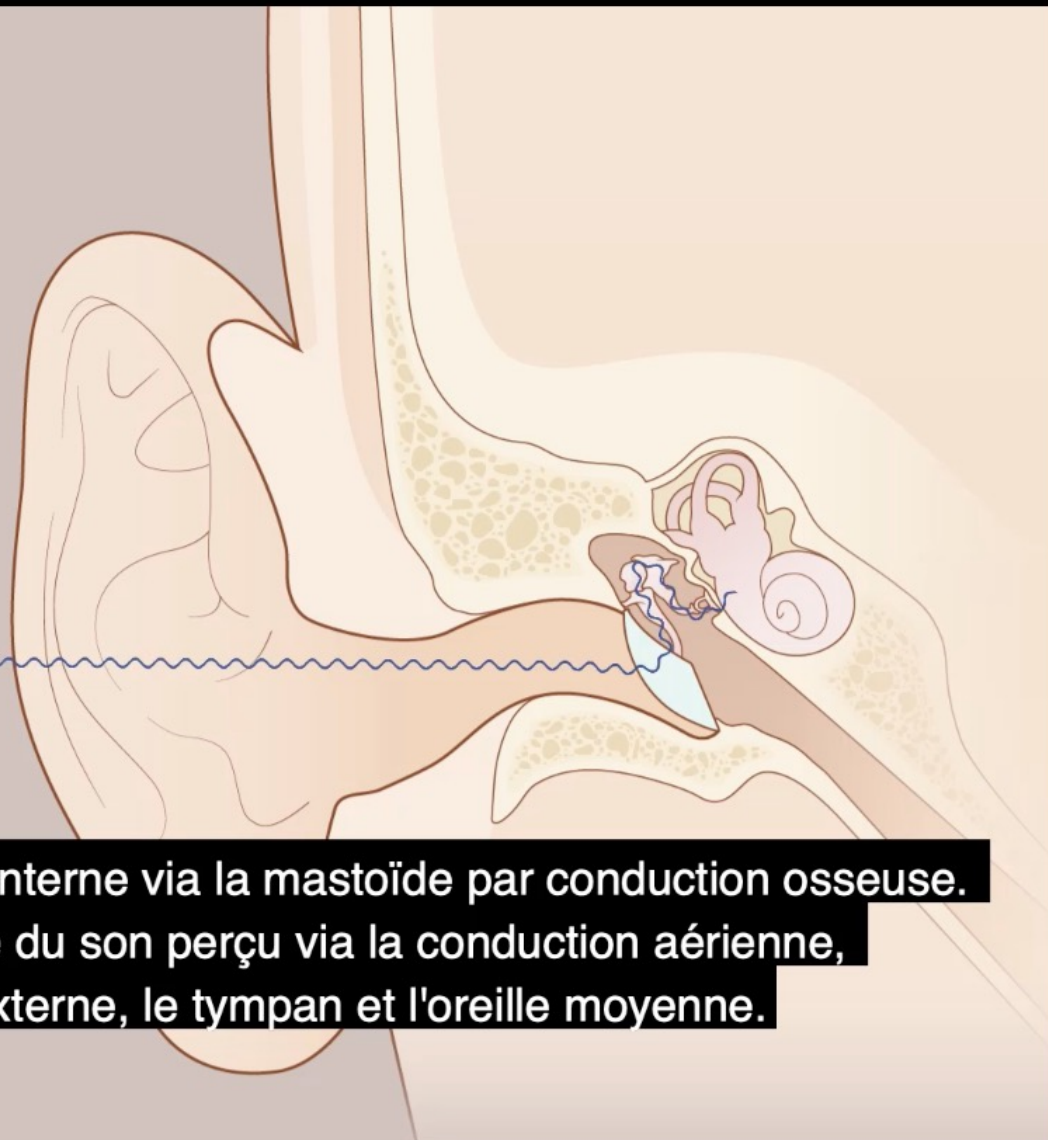


Le son est d'abord délivré à l'oreille interne via la mastoïde par conduction osseuse. Puis, nous le comparons à l'intensité du son perçu via la conduction aérienne, c'est-à-dire via le canal auditif externe, le tympan et l'oreille moyenne.

RINNE



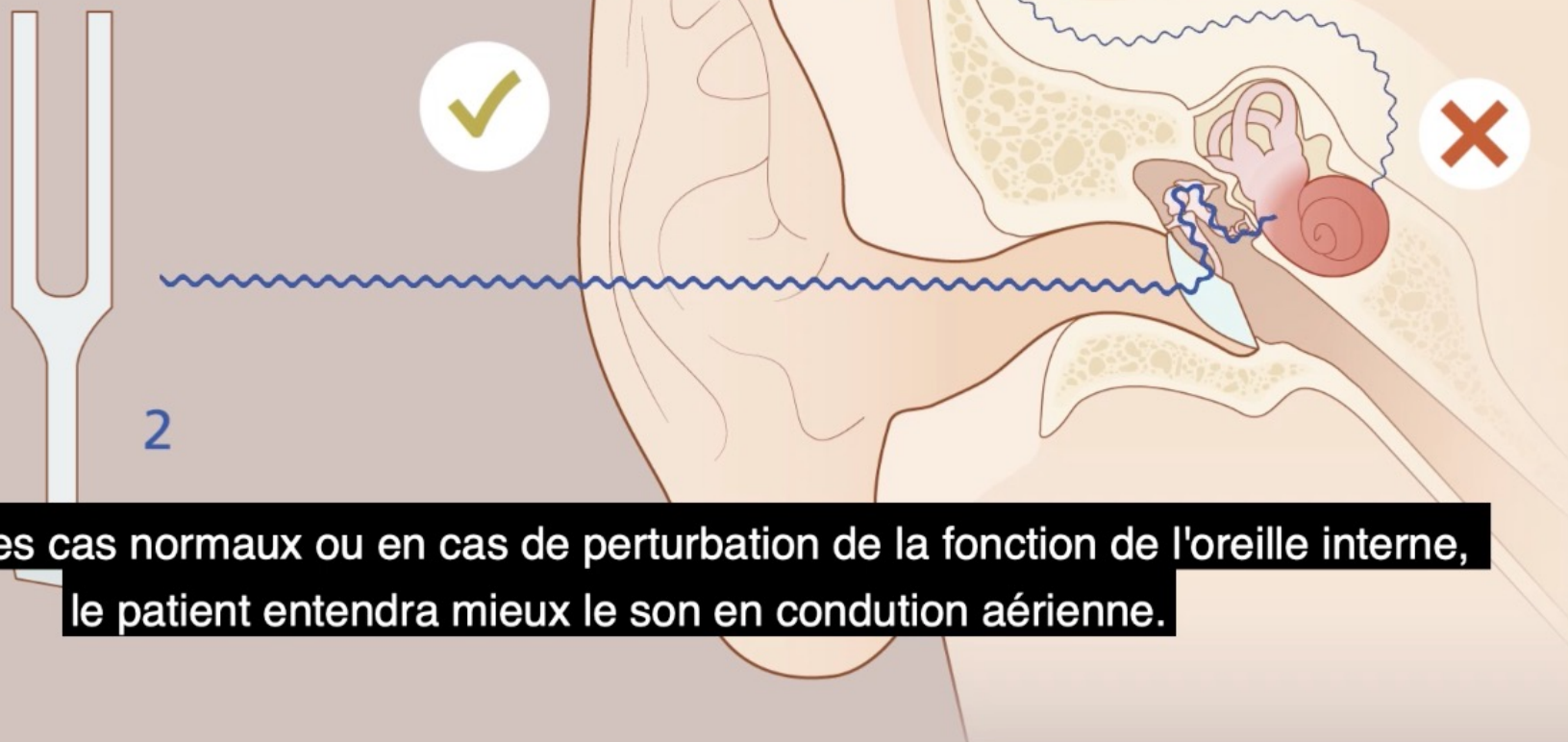
2



Le son est d'abord délivré à l'oreille interne via la mastoïde par conduction osseuse. Puis, nous le comparons à l'intensité du son perçu via la conduction aérienne, c'est-à-dire via le canal auditif externe, le tympan et l'oreille moyenne.

RINNE

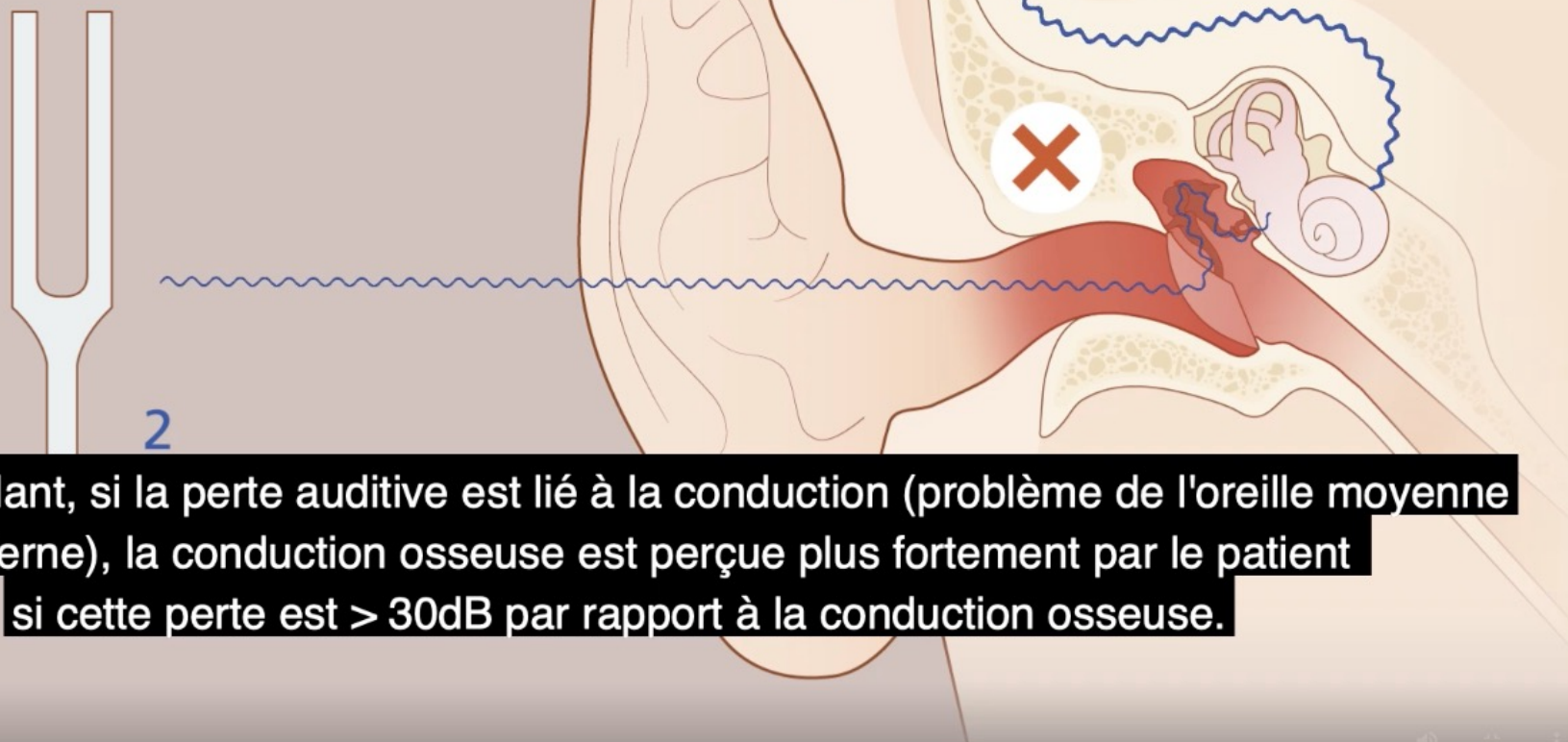
Schwerhörigkeit:
Schallempfindung

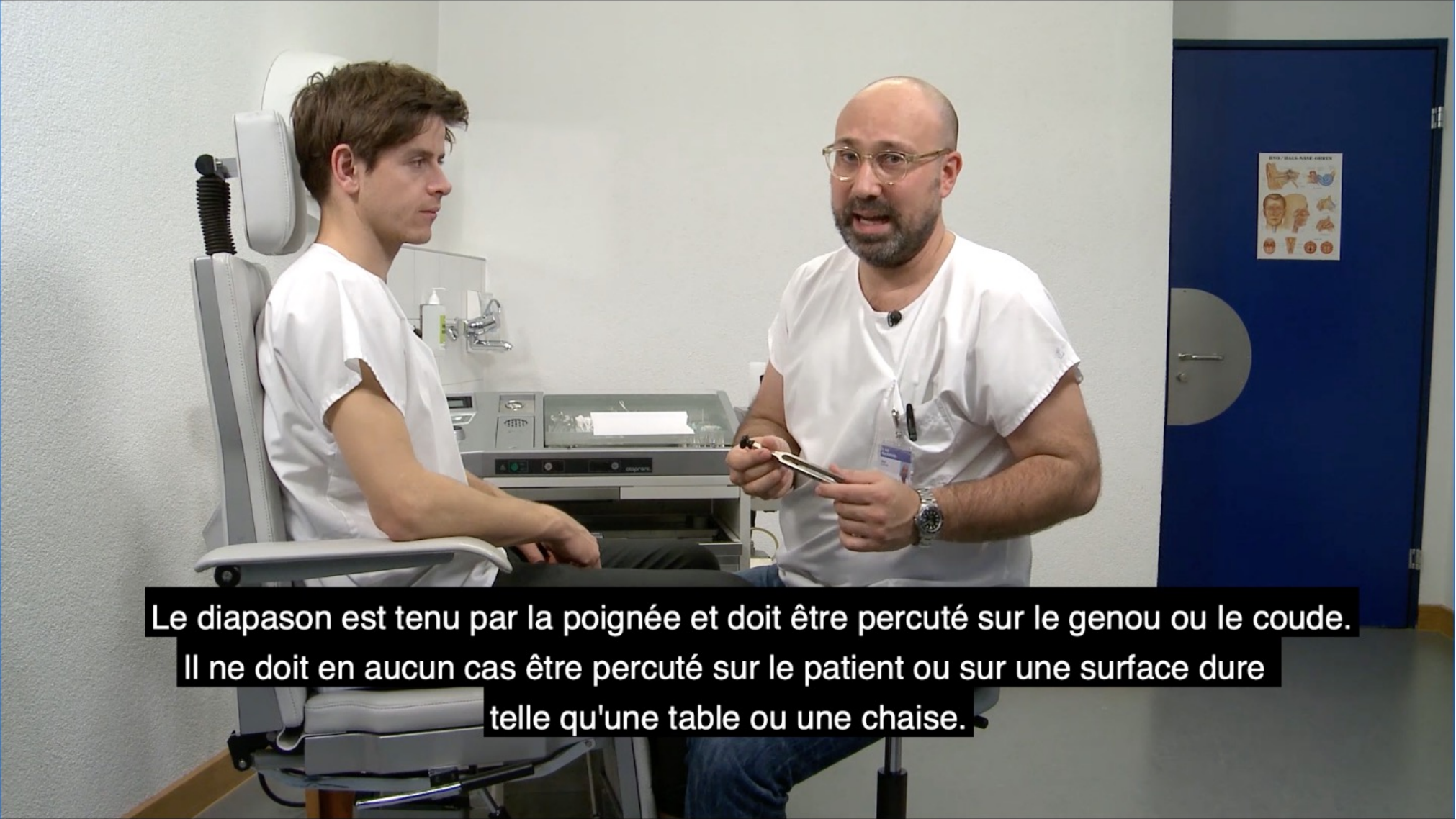


Dans des cas normaux ou en cas de perturbation de la fonction de l'oreille interne,
le patient entendra mieux le son en conduction aérienne.

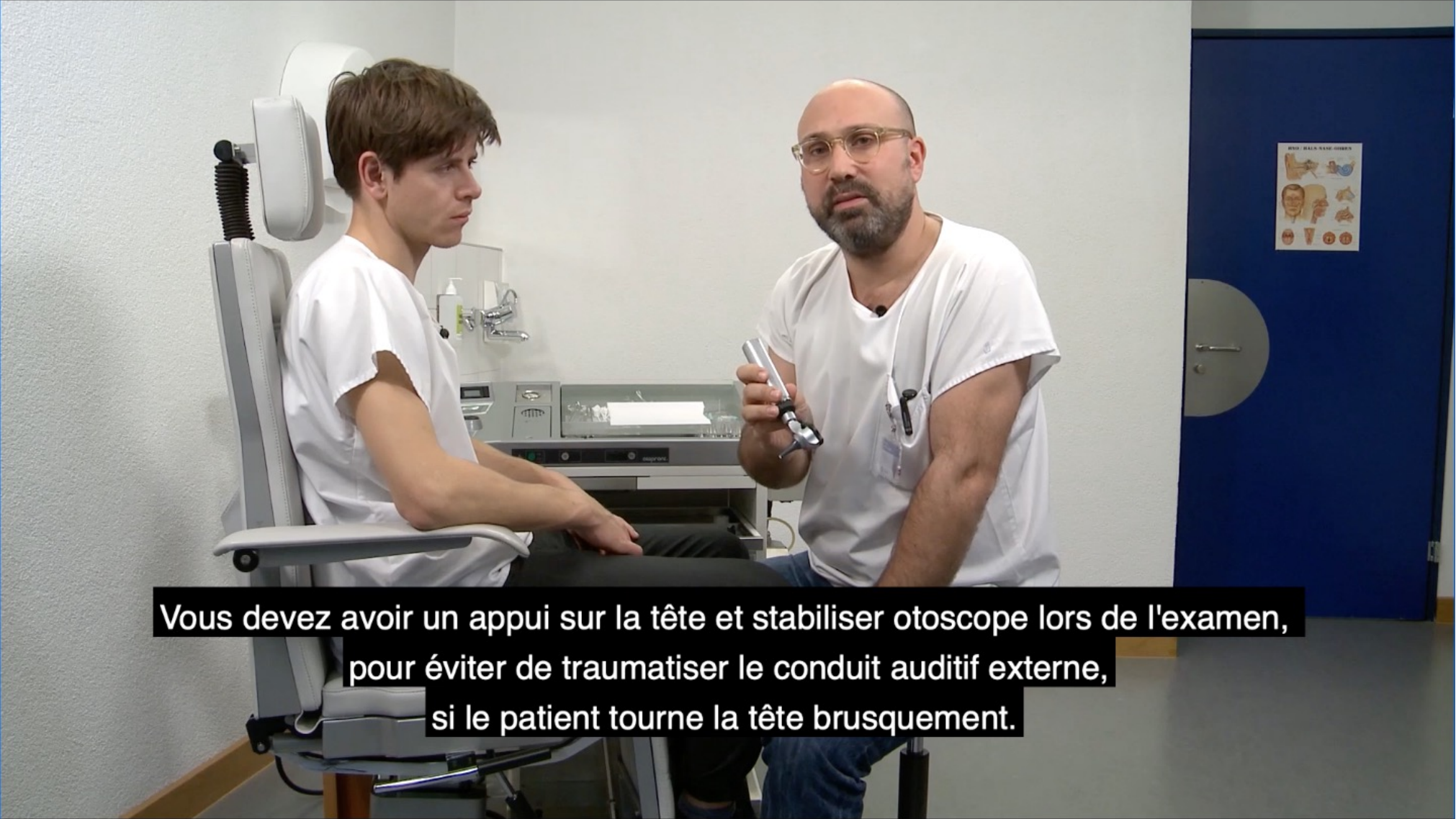
RINNE

Schwerhörigkeit:
Schallleitung





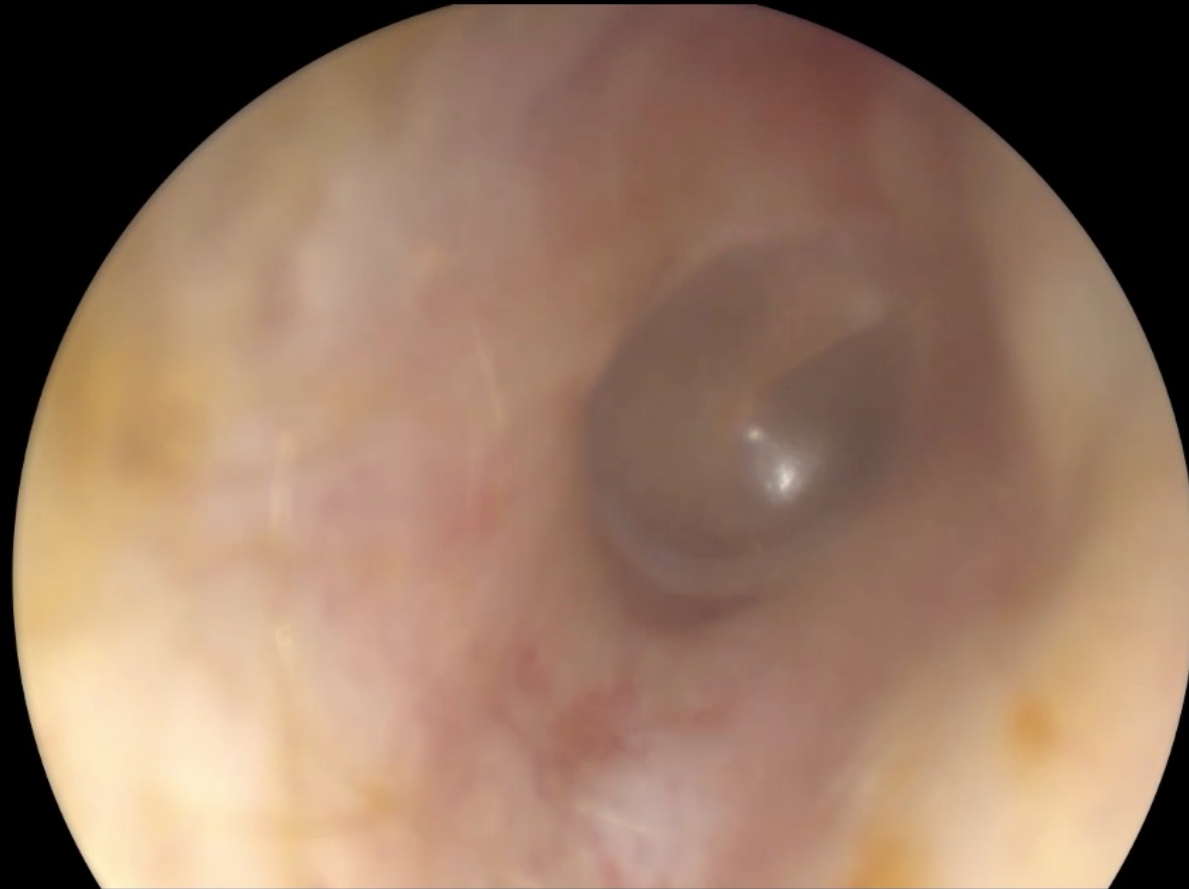
Le diapason est tenu par la poignée et doit être percuté sur le genou ou le coude.
Il ne doit en aucun cas être percuté sur le patient ou sur une surface dure
telle qu'une table ou une chaise.

A medical professional, a man with a beard and glasses wearing white scrubs, is demonstrating an otoscopic examination. He is holding a silver otoscope in his right hand and looking towards the camera. A young man with brown hair, also in white scrubs, is seated in a white medical chair, facing the professional. The setting is a clinical room with a white wall, a blue door on the right, and medical equipment in the background. A poster titled 'HEAD, EAR, NOSE, THROAT' is visible on the door.

**Vous devez avoir un appui sur la tête et stabiliser otoscope lors de l'examen,
pour éviter de traumatiser le conduit auditif externe,
si le patient tourne la tête brusquement.**

A close-up photograph of a person's head from the back and side. The person has short, dark hair. A hand is holding an otoscope to the ear, while another hand pulls the earlobe upwards and backwards. The background is a plain, light-colored wall.

Je tracte le pavillon postérieurement et supérieurement pour mieux exposer le conduit auditif externe.



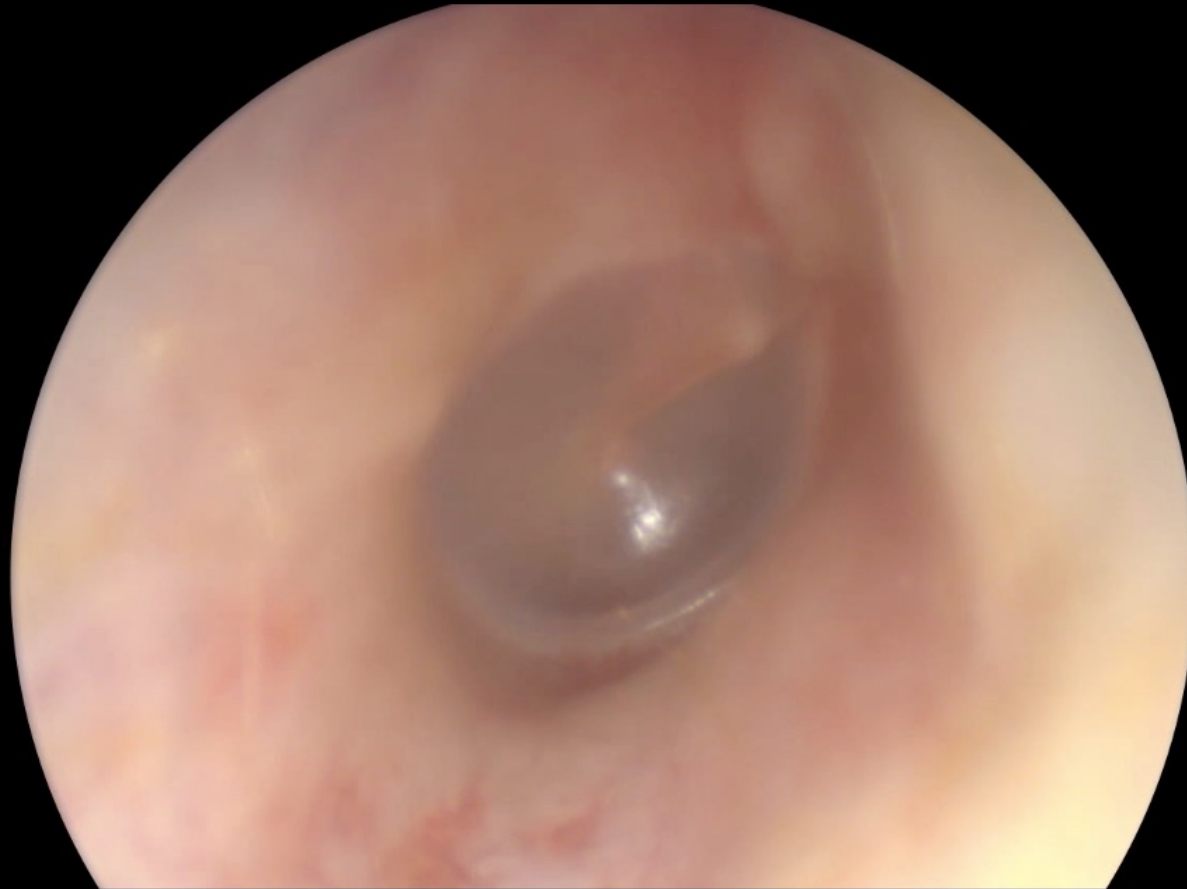
J'insère soigneusement le speculum. Nous voyons les poils et faisant attention à tout changement au niveau du conduit auditif externe et du tympan.



Un tympan normal, comme dans notre cas, est différencié, transparent et non perforé.
La lumière de l'otoscope est réfléchi en antéro-inférieure tel un cône.



La mobilité du tympan peut être testée activement.



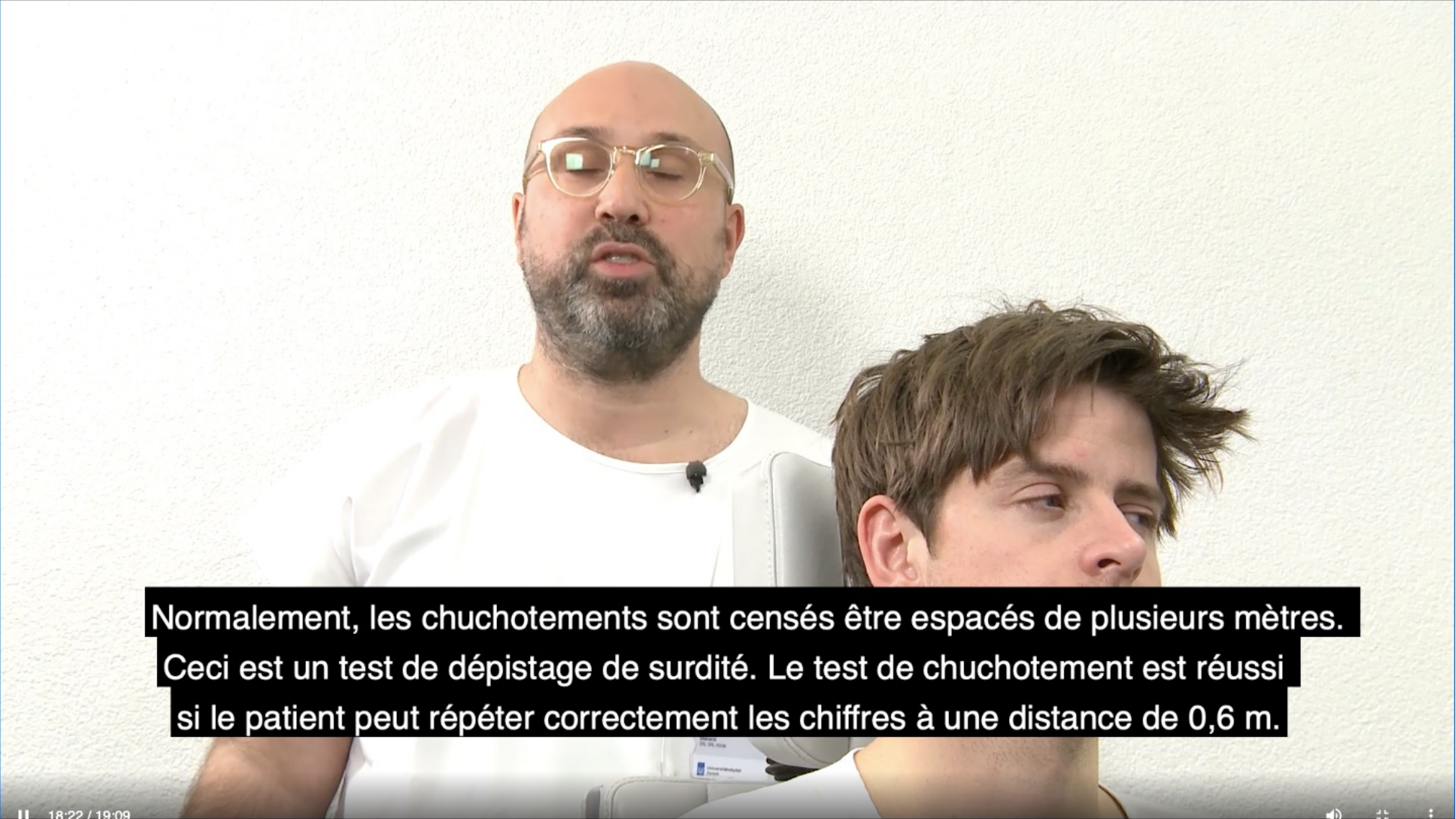
Dans la manoeuvre de Valsalva, le patient est invité à pincer son nez avec ses doigts et à exercer une pression sur les oreilles la bouche fermée.



Un test négatif, donc une absence de mouvement, peut être le signe d'un trouble de la ventilation du tube.



Un chuchotement ou un frottement des doigts peut être utilisé pour évaluer
rossièrement votre audition. Cela est particulièrement important si nous
n'avons pas accès à l'audiogramme tonale.



Normalement, les chuchotements sont censés être espacés de plusieurs mètres. Ceci est un test de dépistage de surdité. Le test de chuchotement est réussi si le patient peut répéter correctement les chiffres à une distance de 0,6 m.